

伴或不伴神经精神症状的巨幼细胞性贫血临床分析

杨 晓

巨幼细胞性贫血主要是由于叶酸或维生素 B₁₂ 缺乏,引起细胞 DNA 合成障碍所致的一组贫血^[1]。巨幼细胞性贫血患者除贫血表现外,可出现手足麻木、共济失调、认知障碍等神经系统受累表现。笔者就我院 2015—2018 年收治的 101 例巨幼细胞性贫血患者临床情况分析报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

101 例患者均于 2015—2018 年在我院住院且经长期随访,符合巨幼细胞性贫血诊断标准,其中男性 34 例,女性 67 例,年龄 12~81 岁,平均 56.5 岁,其中 60~81 岁 65 例。均伴有不同程度的神经精神症状,对所有的患者进行详细病史询问、体格检查,行脑 CT 检查排除脑肿瘤、脑血管病及精神科疾病。

1.2 实验室检查方法

应用全自动血细胞分析仪检测血常规,末梢血涂片,放射免疫法检测血清叶酸、维生素 B₁₂ 水平,骨髓穿刺观察细胞形态。行血糖及甲状腺功能检测,行内因子抗体检测。

1.3 治疗方法

1.3.1 病因治疗:改善膳食结构,纠正不良习惯如酗酒等,富含维生素 B 族饮食,多吃粗粮、蔬菜和动物内脏等,纠正血糖,改善甲状腺功能等。

1.3.2 药物治疗:所有患者给予肌肉注射甲钴胺 0.5 mg/d,叶酸口服 30 mg/d,并发现缺铁性贫血的患者予口服铁剂治疗 0.3 g/d,治疗期间每 3~4 d 复查 1 次血常规。患者平均住院时间为 1~3 周,总疗程为 3~6 个月。所有患者在出院时,症状均有不同程度的好转,出院后继续给予甲钴胺、叶酸等维持治疗。

2 结 果

2.1 临床表现

除有头晕、乏力、面色苍白等贫血表现外,伴四肢麻木无力、行走不稳等神经系统表现者 35 例,其中 6 例为亚急性脊髓后侧索联合变性,有精神症状者如性格改变、暴躁、情绪不稳、焦虑等 11 例。既往史中,长期素食者 15 例,有胃疾病史者 17 例,甲状腺疾病史 7 例(控制不佳),糖尿病史 9 例(控制不佳),酗酒史 4 例。

2.2 实验室检查

大细胞性贫血 96 例,血红蛋白 >90 g/L 4 例,60~90 g/L 66 例,<60 g/L 31 例。单纯维生素 B₁₂ 缺乏 23 例(其中长期素食 12 例),单纯叶酸缺乏 63 例,两者均缺乏 15 例,合并缺铁 18 例,内因子抗体检查阳性 52 例。101 例患者均经骨髓检查

提示为巨幼细胞性贫血。

2.3 影像学及神经电生理检查

35 例有神经精神症状患者均行头颅 CT 检查,部分患者发现多发小缺血灶,15 例有白质脱髓鞘改变;6 例考虑有脊髓损害表现者行头颅磁共振成像(MRI)发现,病灶主要累及脊髓后、侧索,病灶信号呈等 T1 长 T2,轴位呈“八”字征表现。

3 讨 论

本组资料显示,合并神经精神症状的巨幼细胞性贫血并不少见,特别是老年人更易发生,这可能与高龄、长期素食、胃肠道疾病、糖尿病、甲状腺疾病、吸收功能下降、内因子缺乏(如胃炎、胃大部切除术后)及药物等因素,引起维生素 B₁₂ 吸收障碍及叶酸缺乏有关^[2]。

巨幼细胞性贫血患者常就诊血液科,多有面色苍白、心悸等一般表现,经血象、骨髓象等检查诊断贫血。但部分患者在发病初,仅有神经、精神系统症状,此时贫血症状不明显或尚未出现^[3],而且出现贫血后,神经病变的严重程度与贫血的程度并无直线相关性^[4],而与贫血的程度呈负相关,即贫血越重,神经系统损害越轻。这可能是贫血和神经系统损害分别损害了甲基丙二酸单酰 A、变位酶和蛋氨酸有关。以上无论哪种情况,都极易出现误诊或漏诊。我院在 101 例贫血患者中有 9 例出现误诊,而其中有 7 例入院初期考虑为神经系统疾病,可见其误诊率较高。

素食者因摄入不足,可引起巨幼细胞性贫血。但由本组资料可见,表现为单纯维生素 B₁₂ 缺乏者明显较单纯叶酸缺乏者多,其原因可能为素食中叶酸含量较高而维生素 B₁₂ 含量较少。甲状腺激素对维持胃肠道功能有重要作用,甲状腺激素水平异常会导致胃肠功能紊乱^[5]。所以,甲状腺疾病可能会影响胃肠道对维生素 B₁₂ 吸收,进而引起神经精神症状。

健康人摄入的维生素 B₁₂ 必须与胃底壁细胞分泌的内因子结合,形成稳定的内因子-维生素 B₁₂ 复合物,才在回肠远端被吸收而不被肠道细菌利用^[6,7]。针对内因子的 2 个抗原表位,有 2 个抗体亚型,一个是 251-265 氨基酸序列的维生素 B₁₂ 结合位点(IFAb I),另一个是针对与回肠的内因子受体结合的位点(IFAb II)^[8]。IFAb I 可以阻止维生素 B₁₂ 与内因子的结合,IFAb II 可以阻止内因子-维生素 B₁₂ 复合物在回肠的吸收,因此,这 2 种 IFAb 均可以引起维生素 B₁₂ 缺乏。内因子抗体通过以上途径,可以导致有效的维生素 B₁₂ 不足,而此时检测血液维生素 B₁₂ 浓度往往是正常的。故对于检测出内因子抗体阳性的患者,经胃肠道补充维生素 B₁₂ 是无效的,此时需要长期肌肉注射维生素 B₁₂ 进行治疗。

因此,在临床工作中,合并有神经精神症状的巨幼细胞

性贫血患者,如不详细询问病史,尤其是饮食及生活习惯,并进一步做相关检查,排除糖尿病、甲状腺疾病、内因子缺乏等,就容易导致误诊或漏诊。在检查中,对甲状腺功能、血糖、内因子抗体等病因的检测对患者诊治极为重要。如果产生误诊或者漏诊,导致无法及时纠正病因,或者无法进行针对性的治疗,病程就会延长,甚至对神经系统可能造成不可逆损害,引起永久性神经功能缺损。

综上所述,对于合并有神经精神症状的巨幼细胞性贫血患者,不仅要考虑到其与贫血的相关性,还要考虑到其病因的复杂性,要早期诊断,并针对其可能病因完善相关检查,及时给予对应治疗,从而能显著缩短病程,改善患者预后,减少致残率。

参考文献

- [1] 张之南.血液病诊断及疗效标准[M].2版.北京:科学出版社,1998:171-175.
- [2] 韦湘.巨幼细胞性贫血临床分析[J].中国现代医生,2010,48(10):116-117.
- [3] Lindenbaum J,Healton EB,Savage DG,et al. Neuropsychiatric disorders caused by cobalamin deficiency in the absence of anemia or macrocytosis [J]. N Engl J Med,1988,318(318):1720-1728.
- [4] Capdevila AM,Gorjon L,Corredera E,et al. Subacute combined degeneration without anemia[J]. Rev Neural,2000,30:797.
- [5] Sun G,Shi YB. Thyroid hormone regulation of adult intestinal stem cell development:mechanisms and evolutionary conservations[J]. Int J Biol Sci,2012,8:1217-1224.
- [6] Gursoy AE,Kolukisa M,Babacan-Yildiz G,et al. Subacute combined degeneration of the spinal cord due to different etiologies and improvement of MRI findings [J]. Case Rep Neurol Med,2013,2013:159649.
- [7] Briani C,Dalla-Torre C,Citton V,et al. Cobalamin deficiency: clinical picture and radiological findings[J]. Nutrients,2013,5:4521-4539.
- [8] Annibale B,Lahner E,Negrini R,et al. Lack of specific association between gastric autoimmunity hallmarks and clinical presentations of atrophic body gastritis [J]. World J Gastroenterol,2005,11(34):5351-5357.

(收稿日期:2019-11-27)

联用小剂量阿立哌唑治疗女性精神分裂症 代谢综合征临床观察

孙俊伟 王 丽 高红梅 任 虹

由于精神分裂症患者本身的阴性症状和社会功能下降,患者常常生活懒散、久卧少动,这些不良生活方式使得容易出现代谢相关问题^[1]。越来越多的研究显示抗精神病药物尤其是一些非典型抗精神病药物可增加精神分裂症患者患代谢综合征代谢综合征(metabolic syndrome,MS)的风险。这种风险主要表现为体质量增加(腹型肥胖)、糖耐量异常(糖代谢调节异常)、高血压和脂代谢异常等,可使2型糖尿病、心脑血管疾病患病风险明显增高。女性患者由于其激素水平与男性患者存在明显不同,更容易发生代谢风险。代谢相关问题直接或间接影响了抗精神病药物疗效,也影响了患者治疗依从性,增加了治疗的风险,并成为精神分裂症不良预后的主要原因^[2]。

当精神分裂症患者出现MS后,一般的处理原则是改善患者的生活方式及饮食习惯,联合一定剂量的二甲双胍或换药治疗。由于精神分裂症患者的诸多因素往往很难改变生活方式,关于二甲双胍对于精神分裂症患者伴有的MS治疗,临床上不容易掌握。完全换药会增加原有疾病复发的风险,影

响精神症状的波动。多数文献报道阿立哌唑对代谢相关问题影响小,换用阿立哌唑治疗后MS明显改善^[3]。但如果完全换为阿立哌唑治疗,可能会使精神症状波动。维持原药治疗的基础上联用小剂量阿立哌唑观察其对已经发生MS的精神分裂症患者的代谢影响。以期为早期预防及治疗精神分裂症患者代谢问题提供依据。从而减少精神分裂症患者疾病负担,提高患者的综合治疗疗效。

1 资料与方法

1.1 临床资料:收集资料为2014年6月至2019年6月我院门诊、住院年龄在18~60岁临床上出现的MS的女性精神分裂症患者。符合《国际疾病分类第十版》(ICD-10)关于精神分裂症的临床诊断标准。符合中华医学会糖尿病分会MS的诊断标准(CDS2004)^[4]符合以下4项组成成分中的3项或全部者:①超重或肥胖:体质指数(BMI)≥25.0 kg/m²;②高血糖:空腹血糖(FPG)≥6.1 mmol/L,及或已确诊为糖尿病并治疗者;③高血压:收缩压(SBP)≥140 mmHg或舒张压(DBP)≥90 mmHg,及(或)此前已诊断为高血压而接受治疗;④血脂紊乱:甘油三酯(TG)≥1.7 mmol/L及(或)高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)<0.9 mmol/L(男),<1.0 mmol/L(女)。获得受试者、或法定代理人的书面知情同意。排除标准:①妊娠或哺乳

DOI:10.11655/zgwyylc2020.09.039

作者单位:030045 太原市精神病医院早期干预科

通信作者:任虹,Email:420267677@qq.com